

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE AUTOEFICACIA GENERAL (GSE-10)

Eje III: Personalidad • Evaluación de la Creencia Estable en la Capacidad Propia para Afrontar Desafíos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Autoeficacia General (EAG / GSE: 10 reactivos).
Nombre Original	General Self-Efficacy Scale (GSE; Schwarzer & Jerusalem, 1995).
Autores Originales	Dr. Ralf Schwarzer y Dr. Matthias Jerusalem (Universidad Libre de Berlín).
Adaptación Hispana	Baessler y Schwarzer (1996); Sanjuán, Pérez y Bermúdez (2000), UNED, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Autoeficacia general percibida, competencia resolutive y maestría.
Tipo de Instrumento	Autoinforme unidimensional de 10 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (12 a 85 años). Población general, clínica y laboral.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y docente sin fines comerciales bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO COGNITIVO SOCIAL DE BANDURA

La Escala de Autoeficacia General (GSE) se fundamenta de forma directa en la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura (1977, 1997). El constructo de **autoeficacia general** alude a la creencia amplia y estable de un individuo sobre su propia capacidad y competencia personal para resolver con éxito demandas estresantes, superar imprevistos complejos y perseverar ante obstáculos ambientales adversos.

A diferencia de la autoeficacia específica de tarea (ej. dejar de fumar o hablar en público), la autoeficacia general opera como un rasgo de personalidad disposicional que modula la intención de actuar, el nivel de esfuerzo desplegado y la resiliencia frente al fracaso. Las personas con alta autoeficacia perciben las metas complejas como desafíos por conquistar en lugar de amenazas paralizantes.

Bajo la perspectiva neurobiológica, la autoeficacia general se relaciona con una respuesta atenuada del cortisol salival ante pruebas de estrés social agudo (Trier Social Stress Test), una eficiente inhibición gabaérgica en la amígdala facilitada por la corteza prefrontal dorsolateral y un menor consumo glucídico cerebral en áreas límbicas durante la toma de decisiones bajo presión, evidenciando un procesamiento neurocognitivo más económico y calmado.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Área de Competencia Evaluada	Ítems (10)	Nº Ítems	Definición Operativa y Conductas Reflejadas
1. Resolución y Perseverancia	1, 2, 4, 8, 9	5 ítems	Capacidad de perseverar ante barreras y encontrar soluciones alternativas.
2. Ingenio e Imprevistos	3, 5, 6, 7, 10	5 ítems	Confianza en la propia inventiva y calma para sortear situaciones inesperadas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la validación española de Sanjuán et al. (2000; N = 414): coeficiente alfa de Cronbach de 0.87 a 0.92 y omega de McDonald de 0.89. Fiabilidad test-retest $r = 0.82$ a 6 semanas, evidenciando adecuada estabilidad temporal.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica de forma concluyente la unidimensionalidad estricta del constructo (CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.048). Todas las cargas factoriales estandarizadas oscilan entre 0.58 y 0.82.
Validez Concurrente	Correlación positiva robusta con Resiliencia (RS-14, $r = 0.68$), Optimismo (LOT-R, $r = 0.54$), Autoestima (RSES, $r = 0.62$) y Satisfacción Vital ($r = 0.48$). Correlación inversa intensa con Ansiedad Estado/Rasgo (STAI, $r = -0.58$), Depresión (BDI, $r = -0.52$) y Agotamiento emocional en Burnout (MBI, $r = -0.46$).
Sensibilidad al Cambio	Sensibilidad probada en intervenciones basadas en TCC, programas de activación conductual y entrenamiento en habilidades de solución de problemas, con ganancias de $d > 0.65$ postratamiento.
Universalidad Transcultural	Validada en más de 30 países e idiomas (Scholz et al., 2002), demostrando invarianza métrica y ausencia de sesgo por género o cultura.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica mediante una escala tipo Likert de 4 alternativas:

- **Opciones de Calificación:** 1 = «Incorrecto», 2 = «Apenas cierto», 3 = «Más bien cierto», 4 = «Cierto».
- **Sentido de Calificación:** No contiene reactivos invertidos; todos los 10 ítems puntúan de 1 a 4 en la dirección de mayor autoeficacia.
- **Paso Único (Puntuación Total GSE):** Suma aritmética de las puntuaciones otorgadas a los 10 reactivos:

$$\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{10} \text{Ítem}_i$$

- **Rango Total Teórico: 10 a 40 puntos.** A mayor puntuación, mayor autoeficacia percibida y confianza resolutoria ante el estrés.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Autoeficacia	Significación y Conducta Clínica
Baja / Déficit	10 a 28 puntos	Autoeficacia baja (≤ 28)	Sentimientos de indefensión, parálisis ante imprevistos y baja perseverancia. Foco terapéutico prioritario.
Media / Normal	29 a 33 puntos	Autoeficacia moderada	Nivel adaptativo normativo; confianza suficiente en tareas rutinarias con dudas ante eventos críticos.
Alta / Sólida	34 a 40 puntos	Autoeficacia elevada	Excelente sentido de competencia personal, resiliencia ante el fracaso y proactividad constante.

CRITERIO CLÍNICO DE INDEFENSIÓN (CORTE ≤ 28 PUNTOS):

Una puntuación ≤ 28 en la GSE identifica a pacientes con alta susceptibilidad a la indefensión aprendida y baja adherencia terapéutica. El paciente asume de antemano que sus esfuerzos serán inútiles, perpetuando patrones de evitación y abandono de metas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN LA AUTOEFICACIA

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOEFICACIA (FUENTES DE BANDURA):

- **Paso 1 (Identificación del Bloqueo):** Si GSE $\leq$ 28, explorar el colapso de las cuatro fuentes de autoeficacia: experiencias de logro, modelado vicario, persuasión verbal y estados psicofisiológicos.
- **Paso 2 (Gradación de Experiencias de Maestría):** Diseñar tareas conductuales graduadas (paso a paso) para asegurar éxitos tempranos acumulativos y desmontar la profecía de incompetencia.
- **Paso 3 (Reatribución del Éxito):** Atribuir sistemáticamente los logros al esfuerzo y a la habilidad interna del paciente, reencuadrando los errores como oportunidades de aprendizaje técnico.
- **Paso 4 (Criterio de Consolidación):** Un incremento de $\geq$ 6 puntos o alcanzar el rango de autoeficacia moderada ($\geq$ 29 pts) garantiza la reactivación proactiva del paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN PARÁLISIS POR INDEFENSIÓN TRAS FRACASO OPOSITOR

Identificación: Varón de 32 años, opositor a la función pública, consulta tras suspender la fase final por segunda vez. Presenta bloqueo conductual, incapacidad para abrir los libros, rumiaciones de inutilidad y convicción absoluta de que carece de capacidades para aprobar.

Evaluación Inicial GSE (Línea Base): Puntuación Total = **19/40 puntos** (Autoeficacia Baja / Indefensión Crítica). Ítems 1 y 2 puntuados con 1 ("No puedo resolver problemas difíciles incluso si me esfuerzo"). BDI-II concurrente = 18 (depresión leve-moderada).

Plan Terapéutico: 10 sesiones de Entrenamiento en Solución de Problemas (Nezu) y TCC. Se estructuró un cronograma de estudio microfraccionado (método Pomodoro), planificando simulacros de examen controlados para reexperimentar maestría y reduciendo la activación ansiosa anticipatoria.

Reevaluación a las 8 Semanas: Puntuación Total GSE se elevó a **33/40 puntos** (+14 pts, Autoeficacia Moderada/Normativa). El paciente restableció una rutina de estudio sostenida de 6 horas diarias y se presentó con serenidad a una nueva convocatoria de empleo público.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AUTOEFICACIA COGNITIVA VS. DÉFICIT REAL:

Una puntuación muy baja (GSE $<$ 20) puede estar mediada por sesgo cognitivo depresivo o por déficits instrumentales objetivos no reconocidos (falta de formación o recursos materiales reales). Realizar un balance ecológico.

AUTOEFICACIA ILUSORIA O MANÍA:

Puntuaciones máximas de 40/40 en presencia de descalabros laborales graves o conductas temerarias alertan de omnipotencia maníaca o anosognosia ejecutiva (contrastar con pruebas neurocognitivas y MDQ).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio* (pp. 35-37). NFER-NELSON.
2. Sanjuán, P., Pérez, A. M., & Bermúdez, J. (2000). Escala de autoeficacia general: Datos psicométricos de la adaptación para población española. *Psicothema*, 12(Supl. 2), 509-513.
3. Baessler, J., & Schwarzer, R. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la Escala de Autoeficacia General. *Ansiedad y Estrés*, 2(1), 1-8.
4. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.